

ATTESTATION KINÉSITHÉRAPIQUE

Bilan fonctionnel et évaluation de la marche

Patient : SAJED Khalid

Date de naissance : 13/11/1971

Prise en charge actuelle : kinésithérapie en cabinet libéral

Fréquence : trois séances par semaine

1. Contexte médical et fonctionnel

Le patient présente une atteinte neurologique chronique, responsable de séquelles motrices des membres inférieurs, à type de paraparésie spastique, associées à des troubles sensitifs étendus.

Sur le plan fonctionnel, l'état est décrit comme globalement stable, mais marqué par une fatigabilité importante à l'effort, une diminution de l'endurance à la marche et une instabilité locomotrice, majorées lors des déplacements prolongés ou répétés.

2. Modalités actuelles de prise en charge et déplacements

La rééducation est actuellement réalisée en cabinet de kinésithérapie, à raison de trois séances par semaine.

Les déplacements nécessaires pour se rendre au cabinet sont effectués :

- avec une aide technique à la marche,
- avec l'assistance humaine de son épouse, indispensable pour la sécurité, l'équilibre et la prévention des chutes.

Ces déplacements répétés entraînent une fatigue significative, une majoration transitoire des difficultés motrices et une augmentation du risque d'instabilité, notamment avant et après les séances.

3. Bilan fonctionnel locomoteur

3.1 Capacités de marche

- Marche possible uniquement avec aide
- Périmètre de marche limité à quelques minutes
- Apparition rapide d'une lourdeur des membres inférieurs
- Accrochage du pas prédominant à droite en situation de fatigue

3.2 Qualité de la marche

- Marche instable et fluctuante
- Présence d'un steppage et d'un recurvatum du membre inférieur droit

- Dégradation du schéma de marche avec l'effort
- Correction partielle possible lors de la concentration, non maintenue dans la durée

3.3 Endurance et équilibre

- Fatigabilité neuromusculaire précoce
- Diminution progressive de la stabilité dynamique
- Supervision humaine nécessaire pour sécuriser les déplacements

4. Test de Marche de 6 Minutes (TM6)

Objectif

Évaluer la capacité fonctionnelle à la marche, l'endurance à l'effort et le retentissement de la fatigabilité sur la qualité du déplacement.

Conditions de réalisation

- Test réalisé sur sol plat, en environnement sécurisé
- Parcours balisé avec demi-tours réguliers
- Utilisation de l'**aide technique habituelle (canne)**
- Port des chaussures habituelles
- Surveillance continue par le kinésithérapeute
- Pauses autorisées si nécessaire

Le patient a compris les consignes et a fourni un effort conforme à ses capacités.

Déroulement du test

- **0 à 2 minutes** : marche à allure spontanée, relativement stable
- **2^e à 3^e minute** : apparition d'une lourdeur des membres inférieurs avec ralentissement progressif
- **Aux alentours de la 4^e minute** :
arrêt nécessaire en lien avec la fatigabilité neuromusculaire et l'augmentation de l'instabilité
- **4^e à 6^e minute** : reprise possible, avec marche plus lente, schéma dégradé et accrochage du pas droit plus fréquent

Résultats

- Durée totale : **6 minutes**
- Distance parcourue : **185 mètres**
- Nombre d'arrêts : **1**
- Aide technique utilisée : **oui**

Analyse

La distance parcourue est nettement inférieure aux valeurs de référence, traduisant :

- une capacité de marche réduite,
- une intolérance durable à l'effort,
- un retentissement fonctionnel significatif sur les déplacements répétés.

5. Retentissement sur la vie quotidienne

Les limitations fonctionnelles observées ont un **retentissement direct et durable** sur :

- les déplacements extérieurs,
- la répétition des trajets,
- l'accès autonome aux soins.

La nécessité d'une **aide humaine régulière**, associée à la fatigabilité et à l'instabilité, limite les possibilités de mobilité hors du domicile.

6. Conclusion kinésithérapique

Le patient présente une **limitation fonctionnelle durable de la marche**, secondaire à une atteinte neurologique chronique des membres inférieurs, avec **fatigabilité précoce** et **instabilité à l'effort**.

Bien que la prise en charge soit actuellement réalisée **en cabinet à raison de trois séances par semaine**, la **nécessité d'une assistance humaine systématique pour les déplacements**, la **fatigue induite par les trajets répétés** et le **retentissement fonctionnel objectivé** rendent **une prise en charge en kinésithérapie à domicile préférable**, afin d'assurer la continuité des soins dans des conditions adaptées à l'état fonctionnel du patient.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

À _____, le ____ / ____ / ____

Nom et prénom du kinésithérapeute :

Numéro d'exercice (ADELI / RPPS) :

Signature :

Cachet professionnel :